# Pares craneales, pupila, voz y lenguaje

SEMIOLOGIA · Clase 38 · facial, abducens, audición, pupila de Argyll Robertson, cuerdas vocales y afasia

## 1 · FACIAL VII: LA FRENTE LOCALIZA

**VII · Facial**
motor de la mímica; se busca asimetría en reposo, al hablar y al sonreír

se explora con los

**Gestos a pedir**
elevar cejas, arrugar la frente, cerrar los ojos, inflar las mejillas y silbar

si falla el cierre del ojo:

**Parálisis de Bell** F1
parálisis facial periférica: afecta el VII y el orbicular de los párpados

al cerrar con fuerza:

**Signo de Bell** F1
al cerrar con fuerza el ojo no cierra y el globo sube

orienta a lesión

si respeta la frente:

afecta toda la hemicara:

**Periférica**
afecta toda la hemicara, incluida la frente

no se confunde con la

**Central**
respeta la frente (inervación cortical bilateral); afecta el tercio inferior contralateral

para hiperexcitabilidad, el

**Chvostek** F2
percutir delante del meato auditivo y bajo el arco cigomático

si se contrae la cara:

**Positivo** F2
contracción de orbicular, comisura bucal y ala nasal del mismo lado

traduce

**Hiperexcitabilidad del facial**: tetania por hipocalcemia F2

*en el ojo, también se explora el*

## 2 · VI PAR: EL OJO QUE NO ABDUCE

**VI par · abducens**
inerva el recto lateral y abduce el ojo

si falla, produce

**Si falla** F3
ojo desviado hacia dentro (esotropía) y diplopía horizontal peor al mirar al lado enfermo

el paciente adopta una

**Compensación**
gira la cabeza hacia el lado sano

porque es un

**Falso localizador**: es el par más largo; su parálisis aislada no localiza el daño F3

*en el ojo, se mide el*

## 3 · VIII: EL DIAPASÓN SEPARA CONDUCCIÓN DE NEUROSENSORIAL

**VIII · Vestibulococlear**
coclear para oír, vestibular para el equilibrio

*en el oído, se explora el*

se usa el

**Diapasón**
de 512 a 1024 Hz, cuando se detecta hipoacusia

en el vértex:

comparando aire y hueso:

**Weber** F4
base del diapasón en el vértex o la frente: ¿qué oído o el centro?

si es normal:

si va al sordo:

si va al sano:

**Normal**
se oye en la línea media, igual en ambos oídos

**Va al oído sordo** F4
pérdida de conducción

**Va al oído sano** F4
pérdida neurosensorial del oído contrario

**Rinne**
ósea sobre la mastoides y luego aérea a 2-3 cm del conducto; lo normal es que el aire dure más

descarta una

junto con el Rinne define la

define la

completa el

**Tipo de hipoacusia definido**: conducción o neurosensorial

## 4 · PUPILA: LUZ, CERCANÍA, HORNER Y ARGYLL ROBERTSON

**Pupila normal**
2 a 6 mm; menos de 2 es miosis y más de 6 es midriasis

se explora con el

y con la

**Reflejo fotomotor**
la luz contrae la pupila iluminada y, menos, la contralateral (consensual)

**Acomodación**
al enfocar a unos 30 cm la pupila se contrae

si falta y la acomodación sigue:

conservada en la pupila de

**Argyll Robertson** F5
luz no, cerca sí: fotomotor abolido con acomodación conservada

su tríada es la

es el signo de la

**Tríada** F6
miosis, pupilas irregulares y fotomotor abolido con acomodación conservada

Signo clásico de la **neurosífilis** F5

no incluye la

**La ptosis no es de Argyll Robertson** F6
el banco la incluye por error

pertenece al

miosis con ptosis y enoftalmos:

**Síndrome de Horner**
miosis, ptosis y enoftalmos por daño de la vía simpática

en un fumador justifica la

Horner en un fumador: TC de tórax por posible tumor del vértice pulmonar

## 5 · VOZ: DE LA CUERDA VOCAL AL NERVIO

*en la garganta, se estudia la*

**Voz**
sonido por la vibración de las cuerdas vocales con el aire de los pulmones

si falla la aproximación de las cuerdas,

las mueve el nervio

**Disfonía orgánica**
alteración de la aproximación de las cuerdas

**Vago (X)** F8
su rama laríngea inferior o recurrente mueve las cuerdas

una causa neoplásica es el

si se lesiona de un lado:

**Cáncer de laringe** F7
un tumor sobre la cuerda le impide vibrar desde temprano

**Lesión del recurrente**
la cuerda no se aproxima a la sana

su síntoma más frecuente es la

si es de los dos lados:

**Ronquera persistente** F7
síntoma más frecuente; más de 2-3 semanas en un fumador

**Bilateral** F8
voz susurrada (afonía) y tos ineficaz

obliga a examinar la

se distingue del

Examinar la **laringe** sin demora

El paciente conversivo susurra pero conserva la tos

## 6 · LENGUAJE: BROCA Y WERNICKE

**Tres preguntas**
¿habla con fluidez?, ¿entiende lo que se le dice?, ¿puede repetir?

*para el lenguaje se hacen*

si habla fluido sin sentido:

si no fluye pero entiende:

si ni habla ni entiende:

**Afasia de Wernicke** F9
habla fluida pero sin sentido, jerga y parafasias; comprensión gravemente afectada; no repite ni nombra

**Afasia de Broca**
no fluida, comprensión relativamente conservada, repetición afectada

**Afasia global**
mudo, comprensión abolida, no repite; lesión extensa del hemisferio izquierdo

la lesión está en el

la lesión está en el

Lesión del lóbulo temporal (perisilviano); a menudo con anosognosia F9

Lesión frontal anterior del hemisferio dominante

concepto · técnica · síndrome · signo · diagnóstico · desenlace · complicación · causa · síntoma · mecanismo · ejemplo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clases 11d, 11j, 12a, 12c y 06b · Dr. Sotomayor — teoría del docente ( = literatura)